PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL: PRÉ-NATAL, PARTO, PUERPÉRIO, ALEITAMENTO MATERNO E PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins

Cargo: Técnico em Enfermagem · Assunto 6 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando

1. RESUMO TEÓRICO

6.1 Assistência pré-natal

O pré-natal deve ser iniciado **até a 12ª semana** de gestação (captação precoce). O Ministério da Saúde preconiza **no mínimo 6 consultas** (a Rede Alyne, que sucedeu a Rede Cegonha em 2024, recomenda 7 ou mais), com calendário: mensais até a 28ª semana, quinzenais da 28ª à 36ª e semanais a partir da 36ª semana até o parto. Não existe "alta do pré-natal".

Cálculos obstétricos:

- **Regra de Naegele (DPP):** data da última menstruação (DUM) + 7 dias e – 3 meses (ou + 9 meses). Ex.: DUM 10/05 → DPP 17/02.
- **Idade gestacional (IG):** soma dos dias desde a DUM dividida por 7.
- **Altura uterina:** útero palpável na sínfise púbica por volta da 12ª semana, na cicatriz umbilical por volta da 20ª semana; entre 18 e 30 semanas, a altura uterina em cm aproxima-se da IG.

Exames do 1º trimestre: tipagem sanguínea e fator Rh, Coombs indireto (se Rh negativo), hemograma, glicemia de jejum, testes rápidos (HIV, sífilis, hepatites B e C), urina tipo I e urocultura, toxoplasmose, ultrassonografia. Testes rápidos de HIV e sífilis repetidos no 3º trimestre e no parto.

Vacinas na gestação: dTpa a partir da **20ª semana** em cada gestação (protege o RN contra coqueluche), **hepatite B** (conforme situação vacinal), **influenza** (em qualquer idade gestacional) e **covid-19**. Vacinas de vírus vivos atenuados (tríplice viral, febre amarela, varicela) são **contraindicadas** na gestação, salvo situações específicas avaliadas (febre amarela em surto).

Suplementação: ácido fólico (idealmente 30 dias antes da concepção até a 12ª semana – previne defeitos do tubo neural) e sulfato ferroso (a partir da 20ª semana até 3 meses pós-parto).

Sinais de alerta: sangramento vaginal, perda de líquido, cefaleia intensa, escotomas visuais, edema súbito de face e mãos, ausência de movimentos fetais, febre, contrações regulares antes de 37 semanas. **Pré-eclâmpsia**: PA ≥ 140/90 mmHg após a 20ª semana com proteinúria ou lesão de órgão-alvo; **eclâmpsia** é a ocorrência de convulsão; o sulfato de magnésio é a droga de escolha (antídoto: **gluconato de cálcio**; observar reflexo patelar, FR e diurese).

6.2 Parto

Períodos clínicos do parto:

Período	Início e fim	Características
1º – Dilatação	Início das contrações regulares até a dilatação total (10 cm)	Fase mais longa; fase ativa a partir de 5 a 6 cm (diretriz MS 2017)
2º – Expulsivo	Dilatação total até a saída do feto	Puxos; ausculta frequente do BCF
3º – Dequitação (secundamento)	Saída do feto até a saída da placenta	Até 30 minutos; ocitocina 10 UI IM logo após o nascimento (manejo ativo)
4º – Greenberg	1ª hora após a saída da placenta	Maior risco de **hemorragia pós-parto**; observar globo de segurança de Pinard (útero contraído)

Boas práticas (Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal): acompanhante de livre escolha durante todo o trabalho de parto, parto e pós-parto (**Lei nº 11.108/2005**), liberdade de posição e movimentação, oferta de líquidos, métodos não farmacológicos de alívio da dor (banho morno, massagem, bola), contato pele a pele imediato, clampeamento oportuno do cordão (1 a 3 minutos no

RN vigoroso). Não recomendados como rotina: tricotomia, enema, episiotomia, manobra de Kristeller (proibida), amniotomia de rotina.

Frequência cardíaca fetal (BCF) normal: **110 a 160 bpm**.

6.3 Cuidados imediatos ao recém-nascido

- Contato pele a pele e amamentação **na primeira hora de vida**.
- **Índice de Apgar** no 1º e no 5º minuto: frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor (0 a 2 cada; 7 a 10 = boa vitalidade).
- **Vitamina K** 1 mg IM (prevenção da doença hemorrágica do RN).
- **Credé/profilaxia ocular** (atualmente com eritromicina, tetraciclina ou iodopovidona) na 1ª hora.
- Vacina de **hepatite B nas primeiras 12 a 24 horas** (preferencialmente nas primeiras 12 h) e **BCG** o mais precoce possível.
- Testes de triagem neonatal: teste do pezinho (entre o **3º e o 5º dia** de vida), do olhinho, da orelhinha, do coraçãozinho (oximetria entre 24 e 48 h) e da linguinha.

6.4 Puerpério

Divide-se em **imediato** (1º ao 10º dia), **tardio** (11º ao 42º dia) e **remoto** (após o 42º dia). Os **lóquios** evoluem de **rubros** (vermelhos, primeiros 3 a 4 dias) para **serosos** (rosados/acastanhados) e **alvos** (esbranquiçados, a partir do 10º dia). A involução uterina é de cerca de 1 cm por dia. Primeira consulta puerperal: **até o 7º–10º dia** (Primeira Semana de Saúde Integral). Sinais de alerta: febre, lóquios fétidos, sangramento aumentado (hemorragia pós-parto – perda ≥ 500 mL no parto vaginal ou ≥ 1.000 mL na cesárea), dor e calor nas mamas, tristeza intensa (depressão pós-parto).

6.5 Aleitamento materno

Recomendação: **aleitamento materno exclusivo até os 6 meses** e complementado até **2 anos ou mais**. Livre demanda, sem horários rígidos. Não oferecer chupetas, mamadeiras nem chás.

Sinais de **pega correta**: boca bem aberta, lábio inferior virado para fora, queixo tocando a mama, mais aréola visível acima da boca do que abaixo, bochechas arredondadas (não encovadas). Sinais de boa posição: corpo do bebê voltado para a mãe, barriga com barriga, cabeça e corpo alinhados, bebê bem apoiado.

O **colostro** (primeiros dias) é rico em proteínas e anticorpos (IgA). O leite do início da mamada é rico em água; o do final, rico em **gordura** (saciedade e ganho de peso) – por isso a criança deve esvaziar uma mama antes de passar à outra.

Contraindicações ao aleitamento: mãe com **HIV** (no Brasil), HTLV 1 e 2, uso de algumas drogas e medicamentos (antineoplásicos), criança com galactosemia. Hepatite B **não** contraindica (RN recebe vacina e imunoglobulina).

6.6 Programa Nacional de Imunizações (PNI)

Criado em **1973**. Calendário básico da criança (Calendário Nacional de Vacinação – principais vacinas):

Idade	Vacinas
Ao nascer	BCG (dose única) e hepatite B
2 meses	Pentavalente (DTP + Hib + hepatite B), VIP (poliomielite inativada), pneumocócica 10-valente, rotavírus
3 meses	Meningocócica C
4 meses	Pentavalente, VIP, pneumocócica 10, rotavírus
5 meses	Meningocócica C
6 meses	Pentavalente, VIP; covid-19 (esquema conforme vigência)

9 meses	Febre amarela
12 meses	Tríplice viral, pneumocócica 10 (reforço), meningocócica C (reforço)
15 meses	DTP (1º reforço), VIP (reforço, substituindo a VOP desde 2024), hepatite A, tetraviral (ou tríplice viral + varicela)
4 anos	DTP (2º reforço), febre amarela (reforço), varicela
9 a 14 anos	HPV (dose única desde 2024), meningocócica ACWY (11 a 14 anos)

Vias de administração: BCG – intradérmica (0,1 mL, inserção inferior do deltoide direito); rotavírus – oral (não repetir se a criança regurgitar); tríplice viral, febre amarela e varicela – subcutânea; pentavalente, VIP, pneumocócica e meningocócica – intramuscular (vasto lateral da coxa em menores de 2 anos).

A **evolução da BCG** é normal: mácula → pápula → pústula → úlcera → crosta → cicatriz, em cerca de 6 a 12 semanas (até 3 meses); não se faz curativo nem se espreme a lesão. Desde 2019, a ausência de cicatriz **não** indica revacinação.

Rotavírus: 1ª dose até 3 meses e 15 dias; 2ª dose até 7 meses e 29 dias.

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- Regra de Naegele e cálculo da IG.
- Calendário e número mínimo de consultas; início até a 12ª semana.
- dTpa a partir da 20ª semana; vacinas de vírus vivo contraindicadas na gestação.
- Períodos do parto e o 4º período (Greenberg) como de maior risco hemorrágico.
- Boas práticas: acompanhante (Lei 11.108/2005), Kristeller proibida, episiotomia não rotineira.
- Apgar, vitamina K, hepatite B nas primeiras 12–24 h, teste do pezinho do 3º ao 5º dia.
- Lóquios rubros → serosos → alvos.
- Aleitamento exclusivo até 6 meses; pega correta; HIV contraindica.
- Calendário vacinal, vias e idades; evolução da BCG; idades-limite do rotavírus.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **Naegele: "mais 7, menos 3"**.
- **"Doze-vinte"**: útero na sínfise com 12 semanas, no umbigo com 20.
- **"Vinte é dTpa"**: a partir da 20ª semana em toda gestação.
- **"Vivo não entra na barriga"**: vacinas atenuadas contraindicadas na gestação.
- **"Dilata, expulsa, dequita, Greenberg"**: os 4 períodos.
- **Lóquios: "RSA – Rubro, Seroso, Alvo"** (vermelho, rosado, branco).
- **"Boca de peixinho"**: lábio inferior virado para fora na pega correta.
- **"BCG no braço direito, intradérmica"**.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

Gestante informa que a data da sua última menstruação foi 20 de março. Pela regra de Naegele, a data provável do parto será:

(A) 13 de dezembro.
(B) 27 de dezembro.
(C) 20 de dezembro.
(D) 27 de novembro.
(E) 13 de janeiro.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – foram subtraídos 7 dias em vez de somados.

B) Correta – 20 + 7 = 27; março (3) – 3 meses = dezembro (12). DPP: 27 de dezembro.

C) Incorreta – esqueceu-se de somar os 7 dias.

D) Incorreta – foram subtraídos 4 meses.

E) Incorreta – cálculo sem fundamento na regra.

QUESTÃO 02

O período do parto que compreende a primeira hora após a saída da placenta, caracterizado pelo maior risco de hemorragia, é chamado de:

(A) período de dilatação.
(B) período expulsivo.
(C) dequitação.
(D) quarto período ou período de Greenberg.
(E) puerpério remoto.

✔️ **GABARITO: D**

Comentário:

A) Incorreta – a dilatação é o 1º período, até 10 cm.

B) Incorreta – o expulsivo vai da dilatação total ao nascimento.

C) Incorreta – a dequitação é a saída da placenta.

D) Correta – o 4º período (Greenberg) é a 1ª hora pós-dequitação, quando se forma o globo de segurança de Pinard.

E) Incorreta – puerpério remoto começa após o 42º dia.

QUESTÃO 03

Durante a avaliação da mamada, constitui sinal de pega correta:

(A) bochechas encovadas durante a sucção.
(B) lábio inferior voltado para dentro.
(C) boca bem aberta, lábio inferior virado para fora e queixo tocando a mama.
(D) maior parte da aréola visível abaixo da boca do bebê.
(E) ruídos de estalo durante a sucção.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – bochechas encovadas indicam pega inadequada.

B) Incorreta – o lábio inferior deve estar evertido ("boca de peixinho").

C) Correta – são sinais clássicos de pega adequada.

D) Incorreta – deve haver mais aréola visível acima da boca do que abaixo.

E) Incorreta – estalos sugerem que o bebê perde a pega.

QUESTÃO 04

Sobre a vacina BCG, é correto afirmar:

(A) é administrada por via subcutânea no braço esquerdo.
(B) a lesão vacinal deve ser coberta com curativo oclusivo até cicatrizar.
(C) é aplicada por via intradérmica, na inserção inferior do músculo deltoide direito, e a ausência de cicatriz não indica revacinação.
(D) deve ser adiada para os 2 meses de idade junto com a pentavalente.
(E) é contraindicada para todos os recém-nascidos com menos de 3 kg.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a via é intradérmica e o local é o braço direito.

B) Incorreta – a lesão não deve ser coberta nem manipulada.

C) Correta – via ID, deltoide direito; desde 2019 não se revacina pela ausência de cicatriz.

D) Incorreta – a BCG é dada ao nascer, o mais precocemente possível.

E) Incorreta – adia-se a BCG em RN com peso inferior a 2.000 g.

QUESTÃO 05

Em relação à vacinação da gestante, assinale a alternativa correta.

(A) A tríplice viral deve ser aplicada no 3º trimestre.
(B) A dTpa é indicada a partir da 20ª semana em cada gestação, para proteger o recém-nascido contra a coqueluche.

(C) A vacina influenza é contraindicada na gestação.
(D) A vacina contra hepatite B é proibida durante a gestação.
(E) A dTpa deve ser feita apenas na primeira gestação.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a tríplice viral é de vírus vivo atenuado, contraindicada na gestação.

B) Correta – a dTpa é feita a partir da 20ª semana em toda gestação, transferindo anticorpos ao feto.

C) Incorreta – a influenza é recomendada em qualquer idade gestacional.

D) Incorreta – a hepatite B é indicada conforme a situação vacinal.

E) Incorreta – deve ser repetida em cada gestação.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: pré-natal (início, consultas, exames, vacinas, suplementos, sinais de alerta, pré-eclâmpsia); parto (períodos, boas práticas); cuidados ao RN (Apgar, vitamina K, vacinas, triagens); puerpério (lóquios); aleitamento (pega, composição, contraindicações); PNI e calendário.

Quadro-resumo: DPP = DUM + 7 dias – 3 meses; BCF 110–160 bpm; mínimo de 6 consultas; teste do pezinho 3º–5º dia; AME até 6 meses; dTpa a partir de 20 semanas; BCG ID 0,1 mL.

Pegadinhas: aplicar tríplice viral na gestante; aceitar a manobra de Kristeller (proibida); revacinar BCG sem cicatriz; hepatite B contraindicando amamentação.

Erros comuns: confundir dequitação com período de Greenberg; esquecer o limite de idade do rotavírus; achar que o leite do início da mamada é o mais gorduroso.